Estilo UERJ

Simulado 12 Caderno

Prova inédita no formato da UERJ: quatro alternativas, casos longos e a armadilha da banca em cada questão.

50 questões

17 de outubro de 2026

ANTES DE COMEÇAR

Instruções

- São 50 questões de Clínica Médica, com quatro alternativas cada (A a D) e uma única correta.
- Tempo sugerido: 2 horas e 30 minutos, sem consulta, de uma vez só.
- Marque as respostas na folha de respostas da última página, e só depois abra a resolução.
- Nas questões de identificar, faça o teste do resto: liste os achados e veja se a hipótese explica todos. Antes de pedir exame ou tratamento, pergunte qual é o degrau mais simples que resolve e o que o paciente já usa.
- Na correção, anote em qual arma da banca você caiu. É isso que vai para o diagnóstico, não o total.

1 Homem de 58 anos, com carcinoma epidermoide de laringe tratado há três anos com laringectomia total, lobectomia tireoidiana esquerda e esvaziamento cervical, com cálcio normal em todos os controles depois da cirurgia. Por recidiva cervical, terminou há quatro semanas três ciclos de quimiorradioterapia com um quimioterápico trissemanal que exigiu hidratação venosa vigorosa a cada ciclo e deixou perda auditiva bilateral para sons agudos. Há cinco dias com parestesias periorais e cãibras; sinal de Trousseau positivo. Exames: cálcio total 6,9 mg/dL (albumina 3,9 g/dL), fósforo 3,6 mg/dL, potássio 3,0 mEq/L, magnésio 0,8 mg/dL (1,7 a 2,4), PTH 9 pg/mL (15 a 65), creatinina 1,2 mg/dL, 25-hidroxivitamina D 28 ng/mL, fração de excreção de magnésio de 9%. A causa da hipocalcemia é:

A) Hipomagnesemia por perda renal

B) Hipoparatireoidismo pós-cirúrgico

C) Deficiência de vitamina D

D) Síndrome de lise tumoral

---

2 Homem de 69 anos, hipertenso, diabético e tabagista, procura o pronto-socorro por vertigem rotatória há 3 dias, em crises de 15 a 30 segundos, desencadeadas ao deitar e ao virar para a direita na cama, com náusea; entre as crises fica sem tontura e caminha normalmente. Nega cefaleia, diplopia, disartria, disfagia e perda auditiva. PA 150/90 mmHg, glicemia capilar 180 mg/dL. Examinado já sem vertigem: sem nistagmo espontâneo, impulso cefálico normal para os dois lados, sem desvio vertical no teste de cobertura, marcha e coordenação normais. O plantonista, ao ver o impulso cefálico normal num idoso vascular, solicita RM de encéfalo com difusão. O exame mais adequado neste momento é:

A) RM de encéfalo com difusão

B) Angiotomografia de vasos cervicais

C) Manobra de Dix-Hallpike

D) Audiometria com prova calórica

---

3 Homem de 26 anos, com parceria sexual nova há 1 mês e sexo oral e anal sem preservativo, tem há 4 dias febre e dor em punhos, dorso das mãos e tornozelos e, desde ontem, o joelho esquerdo inchado. Há 2 anos teve uveíte anterior, e na época o HLA-B27 foi positivo. Nega disúria, secreção uretral, diarreia e dor lombar. Exame físico: Tax 38,4 °C, tenossinovite dos extensores do punho direito, quatro pápulas com centro pustuloso em dedos e antebraço, derrame no joelho esquerdo. Artrocentese: líquido turvo, 38.000 leucócitos/mm³ com 88% de neutrófilos, sem cristais, Gram sem bactérias; hemoculturas e cultura do líquido em andamento. O exame com maior chance de confirmar a etiologia é:

A) Biópsia sinovial com cultura

B) Pesquisa molecular de gonococo em urina, faringe e reto

C) Ressonância magnética de sacroilíacas

D) Repetir a artrocentese em 48 horas

---

4 Mulher de 78 anos, hipertensa, foi atendida em quatro consultas nos últimos 5 meses. Na primeira, PA 168/92 mmHg: iniciado anlodipino 10 mg/dia. Dois meses depois, edema maleolar bilateral: acrescentada furosemida 40 mg/dia. Na terceira, urgência miccional e perdas urinárias: iniciada oxibutinina. Agora a filha relata esquecimentos novos e constipação. Exame: PA 128/76 mmHg sentada, sem queda ortostática; edema maleolar 2+/4+, sem turgência jugular nem estertores. BNP 45 pg/mL (ref. < 100), albumina 4,0 g/dL, TSH normal, potássio 3,4 mEq/L. O ponto de partida do quadro atual é:

A) Insuficiência cardíaca de fração preservada

B) Edema pelo anlodipino

C) Bexiga hiperativa idiopática

D) Demência de Alzheimer incipiente

---

5 Homem de 39 anos, trabalhador rural no interior do Maranhão, que trabalha na lavoura descalço, é internado com dispneia progressiva e dor torácica há 3 semanas. Leucócitos 16.800/mm³, com 7.400 eosinófilos/mm³ (persistentes em exame de 1 mês atrás). Troponina elevada. Ecocardiograma: espessamento endocárdico apical do VE com trombo apical de 14 mm, padrão de enchimento restritivo inicial, FE 52%. Ressonância: realce tardio subendocárdico difuso. Sem esplenomegalia, vitamina B12 normal e esfregaço sem blastos; pesquisa de FIP1L1-PDGFRA, triptase e sorologia para Strongyloides colhidas, com resultados previstos em 7 a 10 dias; exame parasitológico de fezes, uma amostra, negativo. Sem asma, sinusite ou vasculite; ANCA negativo. Já iniciou heparina. Além da anticoagulação, a conduta inicial mais adequada é:

A) Imatinibe empírico

B) Prednisona em dose alta isolada

C) Aguardar a sorologia para Strongyloides

D) Ivermectina e prednisona em dose alta

---

6 Homem de 66 anos, com dor lombar há 3 meses, é internado por astenia e vômitos. PA 132 × 80 mmHg, sem edema, sem congestão. Creatinina 5,8 mg/dL (1,0 mg/dL há 1 ano), ureia 150 mg/dL, potássio 5,0 mEq/L, bicarbonato 19 mEq/L, cálcio 10,9 mg/dL, Hb 8,7 g/dL. Urina: fita com proteína negativa, mas proteinúria de 24 horas de 3,8 g. Ultrassonografia com rins de tamanho normal, sem hidronefrose. Cadeias leves livres séricas: lambda 5.600 mg/L, kappa 9 mg/L. Mielograma com 34% de plasmócitos clonais lambda. Diurese de 1.400 mL/dia após hidratação. O nefrologista sugere biópsia renal antes de qualquer decisão. A conduta mais adequada é:

A) Biópsia renal antes de tratar

B) Plasmaférese diária por 5 dias

C) Bortezomibe e dexametasona imediatos

D) Hemodiálise imediata

---

7 Mulher de 52 anos, com colangite biliar primária (antimitocondrial positivo), usa ácido ursodesoxicólico 15 mg/kg/dia há 14 meses, com adesão confirmada. Tem prurido moderado que atrapalha o sono. Sem ascite, varizes ou encefalopatia; elastografia hepática de 9,5 kPa; plaquetas 210.000/mm³. Antes do tratamento, fosfatase alcalina de 3,8 vezes o limite superior; agora, fosfatase alcalina de 2,1 vezes o limite superior, bilirrubina 0,9 mg/dL, ALT 1,4 vez o limite superior, albumina 4,1 g/dL e IgG normal. A interpretação da resposta e a conduta são, respectivamente:

A) Resposta inadequada / dobrar a dose de ursodesoxicólico

B) Resposta adequada / associar colestiramina

C) Resposta inadequada / associar bezafibrato

D) Resposta adequada / manter o ursodesoxicólico

---

8 Mulher de 71 anos, com bócio multinodular atóxico acompanhado há 20 anos, nota crescimento rápido do lado direito do pescoço há 5 semanas, com dor local, disfagia e rouquidão. Exame: massa cervical direita de 7 cm, endurecida, fixa, com pele eritematosa; estridor leve ao esforço; linfonodos cervicais aumentados nos níveis III e IV. SpO2 95% em ar ambiente. TSH 1,8 mUI/L. A tomografia mostra massa tireoidiana invadindo traqueia e esôfago e múltiplos nódulos pulmonares bilaterais. A biópsia por agulha grossa revelou carcinoma indiferenciado (anaplásico) da tireoide, com células fusiformes e gigantes, positivo para PAX8 e citoqueratina. A equipe discute cuidados paliativos exclusivos. Antes de decidir entre tratamento sistêmico e cuidado paliativo exclusivo, o exame que define a conduta é:

A) Tireoglobulina sérica e anti-Tg

B) Calcitonina e CEA séricos

C) Pesquisa de BRAF V600E no tumor

D) Pesquisa de corpo inteiro com iodo-131

---

9 Homem de 40 anos, trabalhador de bananal no Vale do Ribeira (SP), chega 40 minutos após ser picado no pé esquerdo ao calçar a bota, de madrugada. Diz que viu "uma aranha marrom, grande e peluda" fugir. Refere dor imediata e intensa, em queimação, que irradia para a perna. Exame: agitado, PA 154 × 92 mmHg, FC 112 bpm, FR 20 irpm, T 36,6 °C. No dorso do pé, duas marcas puntiformes próximas, com eritema discreto, edema leve e sudorese localizada; sem bolha, sem palidez ou placa marmórea, sem área de necrose. Não há ptose, rigidez abdominal, contraturas musculares ou priapismo. Urina de cor normal; hemograma e creatinina normais. O agente mais provável é:

A) Phoneutria (armadeira)

B) Tityus serrulatus (escorpião amarelo)

C) Loxosceles (aranha-marrom)

D) Latrodectus (viúva-negra)

---

10 Adulto tratado de anafilaxia por amendoim com duas doses de adrenalina intramuscular está assintomático há 6 horas e vai receber alta. Para a possível reação bifásica, a medida que, isoladamente, tem maior respaldo é:

A) Anti-histamínico H1 e H2 por 3 dias

B) Prednisona oral por 3 dias

C) Autoinjetor de adrenalina com plano escrito

D) Montelucaste por 2 semanas

---

11 Homem de 57 anos, tabagista de 45 anos-maço e etilista pesado de destilados há 30 anos, recebe diagnóstico de carcinoma espinocelular de seio piriforme, estadiado como T2N1 por TC de pescoço e tórax, sem metástases a distância. Nega disfagia, odinofagia ou perda de peso relevante. Endoscopia convencional com luz branca há 8 meses, feita por dispepsia, mostrou apenas gastrite enantematosa. A equipe programa quimiorradioterapia. Antes de iniciar o tratamento, o exame mais adequado é:

A) Nenhum exame, pela endoscopia recente

B) Esofagograma baritado

C) TC de abdome superior

D) Endoscopia com cromoscopia por lugol

---

12 Homem de 29 anos, negro, com infecção pelo HIV diagnosticada há dois meses (CD4 de 90 células/mm³, carga viral de 310.000 cópias/mL), ainda sem terapia antirretroviral porque faltou às consultas, procura atendimento por urina espumosa. PA 118/72 mmHg, sem edema. Exames: creatinina 2,4 mg/dL, ureia 64 mg/dL, albumina 3,1 g/dL, proteinúria de 6,2 g/24 h, sedimento sem hemácias, sorologias para hepatites B e C e VDRL negativas. Ultrassonografia: rins de 13,5 cm, hiperecogênicos. Biópsia renal: glomerulosclerose segmentar e focal com colapso do tufo, hiperplasia de podócitos e microcistos tubulares. Já foi iniciado IECA. A medida que mais altera o prognóstico renal deste paciente é:

A) Associar inibidor de SGLT2

B) Ciclosporina oral

C) Prednisona 1 mg/kg/dia

D) Iniciar terapia antirretroviral

---

13 Homem de 42 anos, motorista, é levado pela esposa por irritabilidade, impulsividade e 'tiques' há 1 ano: movimentos rápidos, irregulares e sem padrão nos dedos, nos ombros e na face, que ele disfarça emendando um gesto voluntário; perdeu o emprego após dois acidentes. Teve faringoamigdalite há 2 meses, e o clínico pediu antiestreptolisina O, de 420 UI/mL (VR até 200). Foi adotado aos 3 anos e soube recentemente que a mãe biológica 'morreu internada em hospital psiquiátrico' aos 55 anos. Sem uso de neurolépticos, anticoncepcional ou drogas ilícitas. Exame: movimentos coreicos generalizados, impersistência motora (não mantém a língua protrusa), sacadas lentas; sem sopros, artrite ou nódulos. Hemograma, TSH, glicemia e cálcio normais. RM: atrofia das cabeças dos núcleos caudados com aumento dos cornos frontais dos ventrículos laterais. O próximo exame mais adequado é:

A) Pesquisa de acantócitos em sangue fresco

B) Ecocardiograma transtorácico

C) Anticorpos antifosfolípides

D) Expansão de repetições CAG no gene HTT

---

14 Homem de 34 anos, com hemofilia leve (atividade de fator IX de 14%), sem inibidor, será submetido a exodontia de dois terceiros molares inclusos. Teve sangramento prolongado após amigdalectomia na infância e nunca recebeu hemocomponentes ou concentrados de fator. Usa apenas omeprazol. O cirurgião bucomaxilofacial, que trata pacientes com hemofilia leve com desmopressina antes de extrações, propõe o mesmo esquema. Exame físico normal; plaquetas 240.000/mm³, TP normal, TTPa 44 segundos (VR 25 a 35). O preparo hemostático mais adequado é:

A) Desmopressina e ácido tranexâmico

B) Plasma fresco congelado pré-operatório

C) Ácido tranexâmico isolado

D) Concentrado de fator IX e ácido tranexâmico

---

15 Mulher de 44 anos, tabagista, procura o pronto-socorro com dor retroesternal em repouso há 3 horas, sem relação com estresse emocional. Nega febre, quadro gripal ou diarreia nas últimas semanas, e não usa cocaína nem triptanos. PA 128×80 mmHg, FC 82 bpm, exame físico normal. ECG: infradesnivelamento de 1 mm em V5 e V6, transitório. Troponina I ultrassensível de 48 ng/L na chegada e de 1.900 ng/L em 6 horas (referência até 16). A cineangiocoronariografia, feita em 20 horas, mostra placa de 30% na descendente anterior proximal, sem estenose igual ou maior que 50% em nenhuma artéria, fluxo TIMI 3 em todos os vasos. Ecocardiograma: discreta hipocinesia inferolateral, FE 58%, sem padrão apical de balonamento. Hemoglobina, TSH e D-dímero normais. Para esclarecer o mecanismo, o próximo exame mais adequado é:

A) Ressonância magnética cardíaca

B) Cintilografia de perfusão miocárdica

C) Angiotomografia de coronárias

D) Teste de acetilcolina intracoronária

---

16 Homem de 70 anos com DPOC grave (VEF1 32% do previsto), em oxigenoterapia domiciliar contínua com 2 L/min por cateter nasal, estável há 6 meses, vai fazer um voo de 9 horas para visitar a filha. Com o oxigênio habitual, a SpO2 em repouso é de 93%. Não tem pneumotórax prévio, bolhas grandes nem exacerbação recente, e caminha 250 m no teste de 6 minutos. Quanto ao oxigênio durante o voo, a recomendação mais adequada é:

A) Aumentar o fluxo durante o voo

B) Manter o mesmo fluxo de 2 L/min

C) Teste de hipóxia antes de decidir

D) Contraindicar a viagem aérea

---

17 Técnica de enfermagem de 30 anos sofreu, há 1 hora, perfuração do dedo com agulha oca usada em punção venosa de um paciente sabidamente HBsAg reagente e HBeAg reagente. Lavou o local com água e sabão. Ela tomou as três doses da vacina contra hepatite B no curso técnico, há 8 anos, com cartão de vacina que comprova as datas, e nunca dosou o anti-HBs depois disso. Está saudável e não tem imunodeficiência. As sorologias do paciente-fonte para HIV e hepatite C, feitas hoje por teste rápido, são não reagentes. O próximo exame mais adequado para definir a profilaxia contra a hepatite B é:

A) HBV-DNA quantitativo do paciente-fonte

B) HBsAg e anti-HBc da profissional em 30 dias

C) Anti-HBs da profissional, agora

D) Nenhum, por ter esquema vacinal completo

---

18 Gestante de 30 anos, primigesta, com 29 semanas, teve diagnóstico de diabetes gestacional pelo teste de 75 g na 25ª semana (jejum 96, 1 hora 182 e 2 horas 150 mg/dL). Há 2 semanas segue dieta orientada por nutricionista e caminhada diária, com boa adesão. Diário de automonitorização dos últimos 14 dias: glicemias de jejum entre 96 e 104 mg/dL em 10 das 14 medidas; 1 hora após café, almoço e jantar entre 112 e 136 mg/dL em todas as medidas. Ganho de peso adequado, PA 112 × 70 mmHg, ultrassonografia com peso fetal no percentil 58 e líquido amniótico normal. HbA1c 5,4%. A conduta mais adequada é:

A) Insulina NPH ao deitar

B) Glibenclamida antes do jantar

C) Insulina rápida antes das refeições

D) Manter a dieta e reavaliar em 2 semanas

---

19 Mulher de 63 anos, com câncer colorretal e extensas metástases hepáticas, em cuidados paliativos exclusivos, usa morfina oral em dose estável há 3 meses, com dor controlada e evacuações a cada 2 dias com laxativo. Há 2 semanas tem náusea que piora após as refeições, saciedade precoce, plenitude e vômitos de grande volume com alimentos ingeridos horas antes, que aliviam a náusea. Haloperidol iniciado há 5 dias não melhorou. Exame: fígado palpável a 12 cm do rebordo costal, ocupando o epigástrio; abdome sem distensão de alças, ruídos hidroaéreos presentes; toque retal sem fecaloma. Cálcio corrigido 9,6 mg/dL, sódio 136 mEq/L, creatinina 0,8 mg/dL. Sem cefaleia ou déficit neurológico. A causa mais provável da náusea é:

A) Hipertensão intracraniana por metástase

B) Estase gástrica por compressão extrínseca

C) Efeito do opioide na zona de gatilho

D) Obstrução intestinal maligna

---

20 Homem de 58 anos tem gota tofácea há 14 anos, com tofos em cotovelos e mãos e crises mensais. Teve reação de hipersensibilidade grave ao alopurinol e não atingiu ácido úrico abaixo de 6 mg/dL com febuxostate 120 mg/dia. O febuxostate foi suspenso e ele iniciou pegloticase 8 mg EV a cada 2 semanas, com pré-medicação com anti-histamínico e corticoide, após dosagem normal de G6PD; mantém colchicina 0,5 mg/dia. Ácido úrico dosado antes de cada infusão: 0,4; 0,6; 1,1; 6,8 e, hoje, antes da 6ª infusão, 7,4 mg/dL. Está assintomático e não teve reação nas infusões anteriores. A conduta mais adequada é:

A) Infundir com pré-medicação reforçada

B) Associar febuxostate e manter a infusão

C) Encurtar o intervalo para semanal

D) Suspender a pegloticase

---

21 Gestante de 24 anos, primigesta, com 12 semanas, tem Hb 9,9 g/dL, VCM 63 fL, HCM 20 pg, RDW 13,2%, hemácias 5,4 milhões/mm³ e ferritina 96 ng/mL. Usa sulfato ferroso desde a confirmação da gravidez, há 6 semanas, sem mudança na hemoglobina. A eletroforese de hemoglobina mostrou HbA2 de 5,4% e HbF de 1,2%, sem hemoglobinas variantes. Está assintomática, com exame físico normal e baço não palpável. O parceiro, descendente de italianos, é assintomático e nunca fez hemograma. O próximo exame mais adequado é:

A) Hemograma e eletroforese do parceiro

B) Saturação de transferrina da gestante

C) Mutações da alfa-globina na gestante

D) Biópsia de vilo corial imediata

---

22 Mulher de 31 anos, com lúpus eritematoso sistêmico há quatro anos (artrite e fotossensibilidade), em uso de hidroxicloroquina 400 mg/dia. Há dois meses com edema de membros inferiores. PA 124/78 mmHg. Exames: creatinina 0,8 mg/dL, albumina 2,6 g/dL, colesterol total 340 mg/dL, proteinúria de 4,6 g/24 h, sedimento com 3 hemácias por campo, C3 e C4 normais, anti-DNA 1:20. Biópsia renal: espessamento difuso da membrana basal com depósitos subepiteliais globais, sem proliferação endocapilar nem crescentes (classe V isolada, ISN/RPS), índice de cronicidade de 1. Usa losartana em dose plena há seis semanas, sem queda da proteinúria. A conduta mais adequada, além de manter a hidroxicloroquina e o bloqueio do sistema renina-angiotensina, é:

A) Manter e reavaliar em seis meses

B) Glicocorticoide com micofenolato

C) Glicocorticoide isolado em dose alta

D) Belimumabe em monoterapia

---

23 Homem de 61 anos, com diabetes tipo 2 há 6 anos, iniciou semaglutida há 5 meses e perdeu 11 kg (HbA1c de 9,8% para 6,6%). Há 7 semanas tem dor intensa em queimação na coxa e no quadril direitos, pior à noite, seguida em 3 semanas de fraqueza para subir escadas; há 10 dias, dor semelhante começou na coxa esquerda. Exame: atrofia e força grau 3 no quadríceps, nos adutores e no iliopsoas à direita, força grau 4 no tibial anterior direito, patelar abolido à direita, hipoestesia na face anterior da coxa direita; membros superiores normais. RM lombar: protrusão discal L3-L4 à direita, sem compressão radicular evidente. VHS 38 mm/h, CPK normal. ENMG: desnervação em múltiplos miótomos de L2 a L5, inclusive em paravertebrais, à direita mais que à esquerda, com potenciais sensitivos reduzidos. O diagnóstico mais provável é:

A) Polirradiculoneuropatia desmielinizante crônica

B) Radiculoplexoneuropatia lombossacra diabética

C) Radiculopatia compressiva de L3-L4

D) Mononeuropatia femoral diabética

---

24 Mulher de 47 anos, asmática leve, não tabagista, tem há 10 semanas tosse, febre baixa vespertina, sudorese noturna, dispneia progressiva e perda de 7 kg. Recebeu amoxicilina-clavulanato e depois levofloxacino, sem melhora. Radiografias seriadas nas semanas 1, 5 e 9: consolidações periféricas bilaterais nos terços superiores, que poupam a região peri-hilar e permanecem nos mesmos locais. Eosinófilos 2.100/mm³ (19%), IgE total 380 UI/mL. Parasitológico de fezes em três amostras e sorologia para Strongyloides negativos; ANCA negativo; sem neuropatia, sinusite, lesões de pele ou alteração urinária. Nenhum medicamento novo. O diagnóstico mais provável é:

A) Síndrome de Löffler

B) Granulomatose eosinofílica com poliangeíte

C) Aspergilose broncopulmonar alérgica

D) Pneumonia eosinofílica crônica

---

25 Homem de 60 anos está em ventilação mecânica há 8 dias após AVC hemorrágico. No 5º dia, teve febre, secreção traqueal purulenta, piora da oxigenação e infiltrado novo em base direita, e recebeu meropenem, amicacina e vancomicina após coleta de culturas. Precisou de noradrenalina por 24 horas, suspensa desde o 2º dia de tratamento. O aspirado traqueal quantitativo cresceu Pseudomonas aeruginosa (10^6 UFC/mL), sensível a cefepima, piperacilina-tazobactam, meropenem e amicacina; hemoculturas negativas; swab nasal sem MRSA. Hoje, no 3º dia de antibiótico, está afebril, com PaO2/FiO2 subindo de 180 para 290 e leucócitos em queda. Quanto à duração total e ao esquema a manter, respectivamente:

A) 14 dias / cefepima e amicacina

B) 7 dias / meropenem e amicacina

C) 14 dias / meropenem isolado

D) 7 dias / cefepima isolada

---

26 Homem de 22 anos, filho de pais primos em primeiro grau, tem desequilíbrio de marcha progressivo desde os 13 anos e hoje usa cadeira de rodas para distâncias longas. Há 1 ano recebeu diagnóstico de diabetes, em uso de insulina. Queixa-se de palpitações e cansaço aos médios esforços. Ao exame: fala escandida, dismetria bilateral, reflexos patelares e aquileus abolidos, sinal de Babinski bilateral, perda da sensibilidade vibratória e de posição nos pés, pés cavos e escoliose toracolombar. Força proximal preservada e panturrilhas de volume normal; CK 140 U/L (referência até 190). PA 118×74 mmHg, FC 92 bpm, ritmo regular. O neurologista o descreve como 'cadeirante com escoliose e insuficiência cardíaca em investigação'. A alteração cardíaca mais esperada nesta síndrome é:

A) Hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo

B) Bloqueio atrioventricular com indicação de marca-passo

C) Cardiomiopatia dilatada com fibrose posterobasal

D) Prolapso da valva mitral com insuficiência

---

27 Homem de 61 anos, com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida (FE 28%) por miocardiopatia isquêmica, em uso de sacubitril-valsartana, bisoprolol, dapagliflozina, espironolactona 25 mg/dia e furosemida 40 mg/dia, queixa-se de aumento doloroso das mamas há 4 meses, que o constrange a ponto de pensar em parar algum remédio. Classe funcional II, PA 108 × 68 mmHg. Exame: tecido glandular retroareolar bilateral de 4 cm, doloroso, móvel, sem nódulo excêntrico, sem descarga papilar e sem linfonodos axilares; testículos de volume normal, sem massas; sem estigmas de hepatopatia. Exames: testosterona total, LH, estradiol, beta-hCG, TSH, prolactina e função hepática normais; potássio 4,6 mEq/L; TFGe 58 mL/min/1,73 m². A conduta mais adequada é:

A) Suspender a espironolactona, sem substituto

B) Trocar a espironolactona por eplerenona

C) Manter o esquema e iniciar tamoxifeno

D) Mamografia e biópsia do tecido mamário

---

28 Mulher de 64 anos, com cólicas biliares há anos, apresenta icterícia, colúria e prurido há 10 dias, sem febre. Perdeu 1 kg. Exames: bilirrubina total 7,8 mg/dL (direta 6,9), fosfatase alcalina 620 U/L, GGT 780 U/L, ALT 140 U/L, CA 19-9 de 410 U/mL (referência até 37). Ultrassonografia: vesícula de paredes finas com cálculo de 3 cm impactado no infundíbulo, dilatação das vias intra-hepáticas e do ducto hepático comum. Colangiorressonância: estreitamento extrínseco do ducto hepático comum ao nível do infundíbulo, colédoco distal de calibre normal e sem cálculos, sem massa hilar, vesicular ou pancreática e sem linfonodomegalias. A hipótese mais provável é:

A) Carcinoma da vesícula biliar

B) Síndrome de Mirizzi

C) Coledocolitíase

D) Colangiocarcinoma peri-hilar

---

29 Mulher de 31 anos tem lúpus eritematoso sistêmico com nefrite classe IV tratada há 10 meses com pulsos de metilprednisolona, prednisona 1 mg/kg com redução lenta (hoje 10 mg/dia) e micofenolato. Há 6 semanas tem dor na virilha direita, pior ao apoiar o peso e ao subir escadas, que irradia para a face medial da coxa, sem febre. Há 2 semanas, numa emergência, a radiografia de bacia foi laudada como normal, recebeu diagnóstico de bursite trocantérica e fez infiltração local, sem melhora. Exame físico: Tax 36,6 °C, sem dor à palpação do trocânter, dor e limitação à rotação interna do quadril direito, sem derrame em joelhos. Exames: C3 e C4 normais, anti-DNA não reagente, PCR 3 mg/L, urina sem hematúria. O exame a solicitar agora é:

A) Ressonância magnética dos quadris

B) Cintilografia óssea trifásica

C) Tomografia do quadril direito

D) Punção do quadril guiada por ultrassom

---

30 Mulher de 47 anos procura a emergência por odinofagia intensa e febre de 39 °C há 2 dias. Usa losartana há 3 anos e sinvastatina há 2 anos; há 10 dias toma, várias vezes ao dia, um analgésico comum em gotas, comprado sem receita, para cefaleia tensional. Exame: úlceras necróticas nas amígdalas, sem linfonodomegalia generalizada, sem esplenomegalia, sem exantema. Hemograma: Hb 12,8 g/dL, leucócitos 1.100/mm³, neutrófilos 40/mm³, linfócitos 900/mm³, sem linfócitos atípicos, plaquetas 228.000/mm³. Hemograma de rotina há 2 meses: normal. Mielograma: celularidade normal, série granulocítica com parada de maturação em promielócitos, sem blastos e sem displasia. A causa mais provável da neutropenia é:

A) Agranulocitose por metamizol

B) Mononucleose infecciosa

C) Leucemia aguda aleucêmica

D) Neutropenia pela sinvastatina

---

31 Homem de 55 anos, ex-tabagista, tratou tuberculose pulmonar há 8 anos, com cura documentada. Está assintomático: nega tosse produtiva, hemoptise, febre e perda de peso. Uma TC de tórax feita para avaliar nódulo tireoidiano mostrou, no lobo superior direito, cavidade de paredes finas com massa arredondada de 2,5 cm em seu interior, que se desloca com a mudança de decúbito, deixando um crescente aéreo. A imagem está estável em relação à TC de 2 anos atrás, sem espessamento da parede nem novas cavidades. IgG anti-Aspergillus reagente; galactomanana sérica negativa; espirometria com VEF1 de 78% do previsto. A conduta mais adequada é:

A) Embolização eletiva da artéria brônquica

B) Ressecção cirúrgica do lobo superior

C) Observação clínica com imagem periódica

D) Voriconazol oral por 6 meses

---

32 Mulher de 47 anos, no 19º dia de internação após ressecção intestinal extensa por isquemia mesentérica, em nutrição parenteral total exclusiva desde o pós-operatório. Por falta no estoque, a solução de polivitamínicos não é adicionada à bolsa há 16 dias. Há 24 horas evolui com taquicardia, confusão mental e oligúria. PA 92/54 mmHg com noradrenalina a 0,08 µg/kg/min, extremidades quentes, enchimento capilar de 2 segundos. Ecocardiograma: FE de 68% e débito cardíaco elevado. Hemoculturas e cultura da ponta do cateter negativas em 48 horas, procalcitonina 0,3 ng/mL, TC de abdome sem coleção nem sinais de nova isquemia. Gasometria: pH 7,18, bicarbonato 9 mEq/L, pCO2 24 mmHg, lactato 11 mmol/L, saturação venosa central de 84%, glicemia 210 mg/dL. Após 2 L de cristaloide, o lactato não se alterou. A causa mais provável da acidose é:

A) Acidose D-lática do intestino curto

B) Isquemia mesentérica recorrente

C) Deficiência de tiamina

D) Choque séptico por infecção do cateter

---

33 Homem de 66 anos, diabético (HbA1c 6,9%), retorna ao ambulatório 4 meses após AVC isquêmico com hemiparesia direita proporcionada, sem afasia, sem negligência e sem alteração de campo visual, NIHSS 4 na admissão, fora da janela de trombólise. RM: infarto de 12 mm no ramo posterior da cápsula interna esquerda e hiperintensidades periventriculares; angiotomografia sem estenose cervical ou intracraniana; ecocardiograma e Holter de 72 horas normais. Teve alta com AAS 100 mg e clopidogrel 75 mg 'sem data para suspender', atorvastatina 80 mg e losartana 50 mg. Hoje: força grau 5 menos à direita, equimoses nos antebraços, PA média de 142/86 mmHg na MAPA de 24 horas, LDL 62 mg/dL, creatinina 1,0 mg/dL. A antiagregação e a meta de pressão arterial sistólica são, respectivamente:

A) Manter AAS e clopidogrel / abaixo de 130 mmHg

B) AAS isolado / abaixo de 130 mmHg

C) AAS isolado / abaixo de 140 mmHg

D) Anticoagulante oral / abaixo de 130 mmHg

---

34 Homem de 72 anos, com adenocarcinoma de próstata e metástases ósseas, está em gosserrelina trimestral há 2 anos, com PSA nadir de 0,8 ng/mL. As aplicações no último ano foram feitas em unidades diferentes. Agora apresenta PSA de 2,1, 3,9 e 6,4 ng/mL em três dosagens mensais. Está assintomático, sem dor óssea, com função renal normal. Antes de classificar a doença e mudar o tratamento, o exame mais adequado é:

A) Testosterona sérica

B) Cintilografia óssea

C) PET-CT com PSMA

D) Biópsia de metástase óssea

---

35 Mulher de 27 anos tem tosse produtiva diária desde a infância, rinossinusite crônica, otites médias de repetição na infância e dificuldade para engravidar há 3 anos (espermograma do marido normal). TC de tórax: bronquiectasias em lobo médio e língula; coração e vísceras abdominais em posição habitual. Teste do suor com cloreto de 28 mmol/L (ref. < 30), imunoglobulinas séricas normais, alfa-1 antitripsina normal, IgE total normal. Cultura de escarro: Haemophilus influenzae. O próximo exame mais adequado é:

A) Broncoscopia com lavado broncoalveolar

B) Painel genético para fibrose cística

C) Óxido nítrico nasal

D) Repetir o teste do suor

---

36 Homem de 68 anos, hipertenso e diabético, chega a um hospital sem hemodinâmica com dor retroesternal em aperto há 1 hora e 40 minutos, com sudorese. Traz ECG de 2 anos atrás com bloqueio de ramo esquerdo. PA 104×66 mmHg, FC 98 bpm, estertores finos em bases, sem sopros. ECG atual: ritmo sinusal, QRS de 150 ms com morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, supradesnivelamento do ST de 2 mm em DI, aVL, V5 e V6, concordante com o QRS positivo dessas derivações; de V1 a V3, supradesnivelamento discordante de 2 mm com onda S de 22 mm. Sem contraindicação a fibrinolítico. A central de regulação informa que a transferência até o serviço com angioplastia mais próximo levará cerca de 3 horas. O médico assistente pondera que 'o bloqueio de ramo é antigo, então o ECG não serve: melhor colher troponina seriada'. A conduta mais adequada é:

A) Transferência para angioplastia primária

B) Cateterismo eletivo em até 24 horas

C) Fibrinólise imediata e transferência

D) Troponina seriada antes de decidir

---

37 Gestante de 31 anos, secundigesta, com 14 semanas, é encaminhada por hipertensão: PA de 168 x 104 mmHg na primeira consulta, com crises de cefaleia, palpitações e sudorese, uma delas durante a ultrassonografia transvaginal. A gestação anterior, há 4 anos, foi normotensa. Proteinúria negativa, plaquetas e transaminases normais. FC 104 bpm. Usa metildopa 750 mg/dia, iniciada há 1 semana na UBS, sem melhora. Metanefrinas livres plasmáticas: normetanefrina 8 vezes o limite superior, confirmada nas urinárias de 24 horas. Ainda não fez exame de imagem. Quanto ao controle pressórico inicial e ao exame para localizar o tumor, a conduta mais adequada é, respectivamente:

A) Doxazosina / ressonância sem gadolínio

B) Labetalol / ressonância sem gadolínio

C) Doxazosina / cintilografia com MIBG

D) Labetalol / tomografia com contraste

---

38 Mulher de 30 anos, primigesta com 32 semanas, tem lúpus eritematoso sistêmico com nefrite classe IV tratada há 4 anos e em remissão desde então com hidroxicloroquina e azatioprina; usa AAS 100 mg desde a 12ª semana. No início da gestação tinha proteinúria de 0,2 g/24 h e PA 110 × 70 mmHg. Há 3 dias tem cefaleia e edema de face e mãos, sem artrite, exantema ou úlceras orais. Exame físico: PA 162 × 108 mmHg, FC 88 bpm, edema 2+/4+. Exames: Hb 11,8 g/dL, plaquetas 118.000/mm³, creatinina 0,9 mg/dL, ácido úrico 7,4 mg/dL, AST 48 U/L, relação proteína/creatinina urinária de 1,9 g/g, sedimento urinário sem hematúria e sem cilindros, C3 e C4 mais altos que no início da gestação, anti-DNA não reagente, relação sFlt-1/PlGF de 190. O diagnóstico mais provável é:

A) Recidiva de nefrite lúpica proliferativa

B) Pré-eclâmpsia com sinais de gravidade

C) Microangiopatia trombótica por antifosfolípide

D) Púrpura trombocitopênica trombótica

---

39 Gestante de 26 anos, primigesta, com 22 semanas, procura a emergência por cefaleia, um episódio de confusão transitória e petéquias há 2 dias. PA 118 × 74 mmHg, FC 96 bpm, afebril. Hb 7,6 g/dL, esquizócitos 6%, reticulócitos 8%, LDH 1.480 U/L, bilirrubina indireta 2,8 mg/dL, haptoglobina indetectável, Coombs direto negativo, plaquetas 11.000/mm³, TP e TTPa normais, fibrinogênio 360 mg/dL, creatinina 0,9 mg/dL, AST 48 U/L, ALT 39 U/L, proteinúria de fita negativa. Ultrassonografia obstétrica com feto vivo e crescimento adequado. O diagnóstico mais provável e a conduta são, respectivamente:

A) PTT / interrupção da gestação

B) PTT / plasmaférese com corticoide

C) Síndrome HELLP / interrupção da gestação

D) Síndrome HELLP / corticoide e plaquetas

---

40 Mulher de 45 anos, com prolapso de valva mitral e insuficiência mitral moderada conhecidos, tem febre baixa, astenia e perda de 3 kg há 4 semanas. Há 9 dias, numa UPA, iniciou ceftriaxona por suspeita de infecção urinária, que a urocultura não confirmou; o antibiótico foi iniciado na UPA antes de qualquer hemocultura e é mantido até hoje. Melhorou parcialmente e foi encaminhada. Vive em área urbana, sem contato com gado, gatos ou leite não pasteurizado. Hoje: T 37,4 °C, PA 118 × 72 mmHg, FC 88 bpm, sopro sistólico mitral, sem dispneia, sem sinais de IC, sem déficit neurológico. Ecocardiograma transtorácico: vegetação de 6 mm em folheto posterior da mitral, sem abscesso ou perfuração. Três pares de hemoculturas colhidos na internação, há 5 dias, já em uso da ceftriaxona, estão negativos. Creatinina e urina normais. O próximo passo diagnóstico mais adequado é:

A) Sorologias para Coxiella e Bartonella

B) Suspender o antibiótico e repetir culturas

C) PET-CT com FDG de corpo inteiro

D) PCR de amplo espectro (16S) no sangue

---

41 Homem de 66 anos, com DPOC moderada, faz endoscopia por dispepsia: lesão superficial elevada e deprimida (0-IIa+IIc) de 18 mm no antro, sem úlcera nem cicatriz. Biópsias: adenocarcinoma tubular bem diferenciado, tipo intestinal de Lauren; Helicobacter pylori presente. Ecoendoscopia: lesão restrita à mucosa, sem linfonodos perigástricos suspeitos. TC de tórax e abdome sem metástases. A conduta mais adequada para a lesão é:

A) Radioterapia e quimioterapia exclusivas

B) Gastrectomia subtotal com linfadenectomia D2

C) Quimioterapia perioperatória com gastrectomia

D) Dissecção endoscópica submucosa

---

42 Homem de 52 anos, etilista de 1 litro de cachaça por dia e desnutrido, foi internado há 6 dias com sódio de 108 mEq/L, potássio de 2,6 mEq/L, vômitos e confusão leve. Recebeu salina a 0,9% com cloreto de potássio; o sódio foi a 121 mEq/L em 24 horas e a 132 mEq/L em 48 horas, quando já estava lúcido, conversando e caminhando. No 5º dia evoluiu com disartria, disfagia e choro fácil e, hoje, com tetraparesia e sinal de Babinski bilateral, mantendo abertura ocular e movimentos verticais dos olhos ao comando. Afebril; PA 128/80 mmHg, glicemia 96 mg/dL, sódio 138 mEq/L, magnésio 1,9 mg/dL; recebe tiamina desde a admissão. TC de crânio na admissão e hoje sem alterações. O diagnóstico mais provável é:

A) Desmielinização osmótica

B) Encefalopatia de Wernicke

C) Oclusão da artéria basilar

D) Encefalopatia hepática

---

43 Homem de 61 anos, hipertenso há dez anos, com edema há três meses. PA 152/94 mmHg. Exames: creatinina 1,9 mg/dL, albumina 2,9 g/dL, proteinúria de 5,8 g/24 h, sedimento com 25 hemácias dismórficas por campo, C3 e C4 normais, sorologias para hepatites B e C e HIV negativas, crioglobulinas negativas. Imunofixação sérica com pequeno componente monoclonal IgG lambda (0,3 g/dL), relação kappa/lambda livre de 1,4 e sem lesões ósseas. Biópsia renal: expansão mesangial com padrão membranoproliferativo; imunofluorescência com IgG e C3, com kappa e lambda em intensidade semelhante; vermelho Congo negativo; microscopia eletrônica com fibrilas retas, dispostas ao acaso, de 18 a 20 nm de diâmetro, sem organização em microtúbulos. O diagnóstico mais provável é:

A) Glomerulopatia imunotactoide

B) Amiloidose de cadeia leve

C) Glomerulonefrite fibrilar

D) Glomerulonefrite crioglobulinêmica

---

44 Gestante de 29 anos, com 30 semanas, sem cardiopatia conhecida, chega ao pronto-socorro com palpitação de início súbito há 40 minutos. PA 116×72 mmHg, FC 186 bpm, sem dispneia, perfusão normal. ECG: taquicardia regular de QRS estreito, sem onda P visível. A manobra vagal modificada (Valsalva com elevação das pernas) não reverte o ritmo. Após a reversão, o ECG mostra ritmo sinusal com PR normal, sem onda delta; o ecocardiograma é normal. Ela relata 5 episódios semelhantes no último mês, um deles com pré-síncope, e prefere adiar a ablação para depois do parto. Não tem asma. A droga para reverter a crise atual e a profilaxia mais adequada até o parto são, respectivamente:

A) Verapamil intravenoso / metoprolol

B) Verapamil intravenoso / atenolol

C) Adenosina intravenosa / atenolol

D) Adenosina intravenosa / metoprolol

---

45 Homem de 39 anos, que nunca fumou, tem adenocarcinoma de pulmão estádio IV com metástases ósseas e quatro metástases cerebrais de 5 a 12 mm, assintomáticas, sem edema significativo nem efeito de massa. ECOG 1, sem uso de corticoide. Painel molecular do tecido: rearranjo de ALK; EGFR selvagem; PD-L1 em 70% das células tumorais. O tratamento inicial mais adequado é:

A) Pembrolizumabe isolado

B) Alectinibe oral, com RM seriada

C) Radioterapia de crânio total e quimioterapia

D) Quimioterapia com pembrolizumabe

---

46 Mulher de 52 anos tem esclerose sistêmica cutânea limitada há 9 anos, com anticentrômero reagente, telangiectasias e fenômeno de Raynaud. Há 6 meses tem dispneia aos médios esforços, sem tosse. Exame físico: SpO2 95% em repouso, B2 hiperfonética em foco pulmonar, sem estertores e sem edema. Prova de função pulmonar: CVF 94% do previsto e DLCO 38% do previsto. Tomografia de tórax de alta resolução sem doença intersticial. NT-proBNP 620 pg/mL; ECG com desvio do eixo para a direita. O próximo exame e o critério hemodinâmico que confirmará hipertensão arterial pulmonar são, respectivamente:

A) Cateterismo direito / PAPm ≥ 25, POAP ≤ 15, RVP > 3 Wood

B) Cateterismo direito / PAPm > 20, POAP ≤ 15, RVP > 2 Wood

C) Ecocardiograma / PAPm ≥ 25, POAP ≤ 15, RVP > 3 Wood

D) Ecocardiograma / PAPm > 20, POAP ≤ 15, RVP > 2 Wood

---

47 Mulher de 36 anos é internada por confusão e vômitos após 3 dias de gastroenterite. Exames: sódio 116 mEq/L, potássio 4,1 mEq/L, glicemia 61 mg/dL, osmolalidade plasmática 242 mOsm/kg, osmolalidade urinária 410 mOsm/kg, sódio urinário 48 mEq/L, ureia 18 mg/dL, ácido úrico 2,1 mg/dL. Euvolêmica após a hidratação inicial, PA 96 × 60 mmHg, FC 92 bpm, pele pálida e fina, pelos axilares e pubianos escassos. Não usa medicações além de anticoncepcional oral. Há 5 anos, no segundo parto, teve hemorragia por atonia uterina com transfusão de 4 concentrados de hemácias; não conseguiu amamentar e desde então só menstrua com o anticoncepcional, prescrito por ciclos irregulares. TSH 1,9 mUI/L (referência 0,4 a 4,5), T4 livre 0,48 ng/dL (referência 0,9 a 1,8). Tomografia de crânio normal. A equipe registrou SIADH. O diagnóstico mais provável é:

A) Secreção inapropriada de ADH

B) Insuficiência adrenal primária

C) Hipotireoidismo primário autoimune

D) Hipopituitarismo pós-parto (Sheehan)

---

48 Homem de 34 anos, tabagista de 20 maços-ano, procura atendimento por poliúria e polidipsia há 5 meses, com diurese de 6 litros por dia, e dor na região temporal esquerda. Exame físico normal. Sódio 146 mEq/L, osmolalidade urinária 140 mOsm/kg, que sobe para 520 mOsm/kg após desmopressina. RM de sela: ausência do brilho da neuro-hipófise e espessamento da haste. TC de crânio: lesão lítica de bordas bem definidas, sem esclerose, no osso temporal esquerdo. TC de tórax: nódulos e cistos de paredes irregulares e formas bizarras, predominando em lobos superiores e poupando os seios costofrênicos. Cálcio, enzima conversora da angiotensina e eletroforese de proteínas normais. O diagnóstico mais provável é:

A) Doença de Erdheim-Chester

B) Histiocitose de células de Langerhans

C) Linfangioleiomiomatose

D) Sarcoidose

---

49 Homem de 61 anos teve ressecado, com margens livres e sem ruptura, um tumor estromal gastrointestinal (GIST) gástrico de 11 cm, com 9 mitoses por 5 mm² e mutação no éxon 11 do KIT. TC pós-operatória sem doença residual. A duração recomendada do imatinibe adjuvante é:

A) Seis meses

B) Um ano

C) Três anos

D) Cinco anos

---

50 Homem de 34 anos, catador de recicláveis, é internado no 6º dia de febre alta, cefaleia e mialgia intensa em panturrilhas, iniciados 10 dias após trabalhar com as pernas na água de uma enchente. Exame: icterícia de tonalidade alaranjada, sufusão conjuntival bilateral, PA 112 × 70 mmHg, sem edema. Exames: bilirrubina total 14 mg/dL (direta 11), AST 120 U/L, ALT 98 U/L, CK 2.100 U/L, plaquetas 62.000/mm³, ureia 142 mg/dL, creatinina 3,8 mg/dL. A diurese das últimas 24 horas, medida na enfermaria, foi de 1.900 mL, com diurese preservada desde a admissão. O distúrbio eletrolítico mais característico, esperado neste momento, é:

A) Hipocalemia

B) Hipercalemia

C) Hipermagnesemia

D) Hipercalcemia

FOLHA DE RESPOSTAS

Simulado 12

Nome: _____ Data: ___/___/_____ Início: ___h___ Fim: ___h___

1 (A) (B) (C) (D)	2 (A) (B) (C) (D)	3 (A) (B) (C) (D)	4 (A) (B) (C) (D)
5 (A) (B) (C) (D)	6 (A) (B) (C) (D)	7 (A) (B) (C) (D)	8 (A) (B) (C) (D)
9 (A) (B) (C) (D)	10 (A) (B) (C) (D)	11 (A) (B) (C) (D)	12 (A) (B) (C) (D)
13 (A) (B) (C) (D)	14 (A) (B) (C) (D)	15 (A) (B) (C) (D)	16 (A) (B) (C) (D)
17 (A) (B) (C) (D)	18 (A) (B) (C) (D)	19 (A) (B) (C) (D)	20 (A) (B) (C) (D)
21 (A) (B) (C) (D)	22 (A) (B) (C) (D)	23 (A) (B) (C) (D)	24 (A) (B) (C) (D)
25 (A) (B) (C) (D)	26 (A) (B) (C) (D)	27 (A) (B) (C) (D)	28 (A) (B) (C) (D)
29 (A) (B) (C) (D)	30 (A) (B) (C) (D)	31 (A) (B) (C) (D)	32 (A) (B) (C) (D)
33 (A) (B) (C) (D)	34 (A) (B) (C) (D)	35 (A) (B) (C) (D)	36 (A) (B) (C) (D)
37 (A) (B) (C) (D)	38 (A) (B) (C) (D)	39 (A) (B) (C) (D)	40 (A) (B) (C) (D)
41 (A) (B) (C) (D)	42 (A) (B) (C) (D)	43 (A) (B) (C) (D)	44 (A) (B) (C) (D)
45 (A) (B) (C) (D)	46 (A) (B) (C) (D)	47 (A) (B) (C) (D)	48 (A) (B) (C) (D)
49 (A) (B) (C) (D)	50 (A) (B) (C) (D)		